

MeuDocMed: Protótipo de Sistema para Centralização de Documentos de Saúde do Paciente

1. Introdução e contextualização do problema

A fragmentação dos registros de saúde é uma realidade enfrentada cotidianamente por pacientes e profissionais de saúde no Brasil. Quem já precisou reunir exames, laudos e receitas de diferentes atendimentos sabe o quanto esse processo pode ser trabalhoso: documentos ficam dispersos entre diferentes serviços, arquivos físicos em casa e registros digitais em aplicativos distintos. Quando o paciente chega a uma nova consulta, frequentemente não dispõe do histórico necessário para que o profissional compreenda sua situação clínica de forma completa.

Esse cenário se agrava no contexto da saúde pública, onde um mesmo paciente pode ser atendido em diferentes unidades ao longo do tempo, como Unidades Básicas de Saúde, prontos-socorros e serviços especializados, sem que nenhuma delas tenha acesso ao que foi realizado nas demais. Cada sistema registra o que lhe compete, mas não há integração entre eles do ponto de vista do paciente.

2. Identificação do problema

A fragmentação dos registros de saúde tem origens estruturais que podem ser organizadas em três aspectos principais.

O primeiro é o isolamento dos sistemas existentes. Muitas unidades de saúde já utilizam prontuários eletrônicos próprios, porém esses sistemas foram desenvolvidos para uso interno de cada unidade e não se comunicam entre si. O segundo aspecto é o foco no profissional e na instituição, e não no paciente. Esses sistemas foram concebidos para registrar consultas e receituários sob a perspectiva do serviço, sem que o próprio paciente tenha acesso direto ou portabilidade sobre seus dados. O terceiro é a ausência de uma visão longitudinal do cuidado, uma vez que nenhum sistema acompanha o percurso do paciente ao longo do tempo, entre diferentes serviços e níveis de atenção.

É necessário, contudo, reconhecer as limitações do diagnóstico aqui apresentado. Não foi realizada pesquisa de campo com pacientes ou profissionais de saúde para validar essas hipóteses. Questões centrais permanecem em aberto: como seria a adesão real dos pacientes a uma

ferramenta desse tipo, especialmente os mais vulneráveis; de que forma ela se integraria à rotina dos serviços; e qual seria seu impacto prático na qualidade do atendimento. Essas perguntas demandariam investigação empírica antes de qualquer proposta de solução em escala.

3. Hipótese e abordagem

A hipótese central que orienta este trabalho é a de que o paciente deveria ter acesso centralizado ao próprio histórico de saúde, com controle sobre quem pode visualizar seus dados e em quais condições.

Do ponto de vista da solução mais adequada, é importante pontuar que a criação de um novo sistema isolado provavelmente não seria a resposta mais eficiente. A abordagem mais promissora seria a integração entre os sistemas de prontuário já existentes, com a criação de uma camada de acesso unificado para o paciente, que reunisse automaticamente os registros das diferentes unidades onde ele foi atendido, sem necessidade de inserção manual de documentos.

O MeuDocMed não realiza essa integração. Trata-se de um protótipo funcional desenvolvido para ilustrar, de forma concreta, como esse cenário poderia operar na prática: o paciente como titular do próprio histórico de saúde, com autonomia sobre o compartilhamento das informações.

4. Desenvolvimento da solução

O MeuDocMed foi desenvolvido como uma aplicação web utilizando a linguagem Python com o framework Flask, banco de dados relacional e suporte a armazenamento de arquivos. A escolha por tecnologias consolidadas e de baixo custo de infraestrutura foi intencional, buscando demonstrar que a viabilidade técnica de uma solução como essa não exige recursos excepcionais.

As funcionalidades implementadas organizam-se em torno de dois perfis de usuário: o paciente e o profissional de saúde.

O paciente pode cadastrar documentos de saúde em diferentes categorias, como exames laboratoriais, exames de imagem, laudos, receitas e registros de vacinação, além de manter uma lista de medicamentos em uso contínuo. O sistema também registra um histórico de acessos, permitindo que o paciente saiba quem visualizou seus dados e em que momento.

O profissional de saúde pode solicitar acesso temporário ao prontuário de um paciente específico. Essa solicitação precisa ser aprovada pelo próprio paciente, que define o prazo de acesso e se permite ou não o download dos arquivos. O acesso pode ser revogado a qualquer momento. Uma vez com acesso ativo, o profissional também pode inserir documentos em nome do paciente, como resultados de exames solicitados ou relatórios elaborados durante o atendimento. Essa funcionalidade reconhece que, na prática, grande parte dos documentos clínicos é produzida pelos próprios serviços de saúde, e não pelo paciente. Ainda assim, o profissional não pode excluir documentos nem acessar qualquer prontuário sem que haja uma permissão prévia concedida pelo paciente.

O sistema prevê também uma configuração de acesso menos restrito para equipes de UBS vinculadas ao território do paciente. Nesse modelo, profissionais da unidade de referência do paciente poderiam ter acesso facilitado ao prontuário, sem necessidade de solicitação individual a cada atendimento, aproximando-se do funcionamento real da atenção básica, onde o vínculo entre equipe e paciente é contínuo. Essa possibilidade de configuração reconhece que nem todo acesso profissional precisa ser tratado da mesma forma: há uma diferença entre um especialista desconhecido solicitando acesso pontual e a equipe de saúde da família que acompanha o paciente regularmente.

Há também a possibilidade de compartilhamento por link temporário, voltada a situações em que o paciente precisa apresentar documentos a um profissional que não está cadastrado na plataforma.

O princípio que orienta o desenho do controle de acesso é que o paciente não perca a autonomia sobre seus dados ao compartilhá-los. O profissional solicita, o paciente decide, e o acesso tem prazo definido.

5. Limitações

Este protótipo apresenta limitações relevantes que precisam ser explicitadas.

A primeira e mais significativa é a ausência de integração com sistemas existentes. O paciente precisa inserir os documentos manualmente na plataforma, o que representa uma barreira real de uso e contradiz parte da proposta de centralização automática do histórico. A possibilidade de inserção por profissionais atenua parcialmente esse problema, mas não o

resolve de forma estrutural.

A segunda limitação é a falta de estudo sobre adesão. Não há evidências, neste trabalho, de que pacientes utilizariam a ferramenta de forma contínua e consistente, nem de que o esforço de inserção manual seria sustentável a longo prazo.

A terceira é que a jornada do paciente não foi mapeada empiricamente. As decisões de projeto partem de hipóteses plausíveis, mas não verificadas junto ao público-alvo.

Por fim, há uma limitação estrutural: se os sistemas de prontuário eletrônico já utilizados pelas unidades de saúde incorporassem funções de exportação e compartilhamento controlado pelo próprio paciente, uma plataforma como o MeuDocMed se tornaria desnecessária. Essa pode ser, inclusive, a via mais viável e realista para o problema identificado.

6. Considerações finais

O MeuDocMed cumpre o papel de exercício de concretização: transforma uma hipótese em algo tangível o suficiente para ser analisado, discutido e criticado. O desenvolvimento demonstra que os aspectos técnicos da solução são viáveis e acessíveis. O desafio real, no entanto, está em outro plano: na adesão dos usuários, na integração institucional entre sistemas e na mudança de cultura dentro dos serviços de saúde, para que o paciente passe a ser reconhecido como titular ativo dos próprios dados clínicos.